CLÍNICA MUV · PARA MAQUETAR

SEDE TRES CANTOS · FISIOTERAPIA DE ESPALDA, CERVICAL Y LUMBAR

*Este documento es **solo para maquetar**: trae el texto exacto que va a la web, los encabezados y las notas de maquetación. Nada más.*

- **URL:** `/sedes/tres-cantos/fisioterapia-espalda`
- **Encabezados:** 1 H1 + 9 H2 + 22 H3 · 8 preguntas frecuentes. El municipio va en el H1 y en un H2, y en ningún H3. Van tal cual: no se reformulan, no se reordenan y no se les añade el municipio.

Title

`Fisioterapia de espalda y ciática en Tres Cantos | MUV`

Meta description

`Lumbalgia, ciática, hernia discal y cervicalgia: valoración y ejercicio para recuperar función. Fisioterapia de espalda en Tres Cantos. Pida cita en MUV.`

> **Estado: borrador.** Lo marcado **en rojo** es un dato que MUV todavía no ha facilitado: **no se maqueta, no se rellena con algo parecido y no se inventa.** Si un bloque depende de un dato rojo, ese bloque espera. La página no se publica en producción hasta que contenidos lo confirme.

⚠ Esta página tiene 2 datos pendientes

Módulo	Qué falta
Quién le atiende	**formación del fisioterapeuta, y foto con su permiso**
Dónde estamos y cuándo abrimos	**aparcamiento, accesibilidad de la entrada y transporte**

Todo lo de esta tabla aparece también en rojo dentro de su módulo.

Módulo 1 · Hero

H1

> Fisioterapia de espalda, cervical y lumbar en Tres Cantos

Entradilla

> ¿Le duele la espalda al levantarse, al final de la jornada o cada vez que vuelve a entrenar? En MUV Tres Cantos hacemos fisioterapia de espalda y cuello: valoramos su caso, calmamos el dolor y trabajamos con usted para

> recuperar el movimiento y la fuerza. El objetivo no es solo que duela menos hoy. Es que vuelva a hacer lo que hacía y que sea menos probable que el dolor reaparezca.

Lo esencial

> - Dolor lumbar y cervical, ciática, hernias y protrusiones, y dolor de espalda que vuelve.
> - Terapia manual, neuromodulación, ejercicio terapéutico, movilidad y fuerza. El ejercicio es el centro.
> - Una hernia o una protrusión en una resonancia no siempre explica el dolor.
> - Un único fisioterapeuta colegiado lleva su caso de principio a fin.

Botones

> `[Pedir cita]` · `[Dónde estamos]` *(ancla al módulo 10)*

Módulo 2 · Qué tratamos

Eyebrow: Motivos de consulta

H2

> Dolores de espalda y de cuello que tratamos en Tres Cantos

Entradilla

> Dolor que se levanta con usted, que empeora al final del día o que vuelve cada pocos meses.

H3 · Dolor lumbar, lumbalgia y lumbago

> Dolor en la parte baja de la espalda, con o sin rigidez, al levantarse, agacharse, estar sentado o entrenar. Es muy común. Las guías recomiendan mantenerse activo y hacer ejercicio.

H3 · Ciática

> Dolor que baja desde la zona lumbar o el glúteo por una pierna, a veces con hormigueo o debilidad. Es un síntoma, no una enfermedad: puede venir de causas distintas y por eso se valora cada caso.

H3 · Hernia discal y protrusión

> El disco es un amortiguador entre vértebras: puede abombarse (protrusión) o salirse de su sitio (hernia). La protrusión se ve en las pruebas de imagen de muchas personas sin dolor, y por eso conviene interpretar los hallazgos con cuidado.

H3 · Dolor cervical, cervicalgia y tortícolis

> Dolor y tensión en el cuello, a veces hasta los hombros o la cabeza. Empeoran con las horas de pantalla o de volante.

H3 · Dolor de espalda que vuelve

> Episodios que mejoran y reaparecen. Aquí es donde más aporta la fisioterapia: tratar el episodio y preparar la espalda para el siguiente. Una revisión Cochrane de 2010 encontró evidencia moderada de que seguir con ejercicio después del episodio ayuda a prevenir las recurrencias.

H3 · Rigidez por muchas horas sentado

> Espalda y cuello que se bloquean tras la jornada. Se trabaja con movilidad, fuerza y pausas activas.

Módulo 3 · Cómo trabajamos

H2

> Cuatro fases para recuperar la función de la espalda

H3 · Valoramos

> Qué le pasa, desde cuándo y qué lo empeora o lo alivia. Exploramos la espalda y también la cadera y las piernas. Y buscamos las señales que exigirían ver antes a su médico.

H3 · Aliviamos

> Reducimos el dolor para que pueda moverse. Se usan la terapia manual y la neuromodulación, cuando la valoración lo indica y siempre como apoyo del movimiento.

H3 · Movemos

> Recuperamos la movilidad de la espalda, el cuello, la cadera y los hombros.

H3 · Fortalecemos

> Fuerza de espalda, abdomen, glúteos y piernas. Es la fase que más pesa a medio plazo, porque es lo que mantiene la mejoría y reduce las recaídas. La clínica ofrece además clases de entrenamiento funcional supervisado en Tres Cantos.

Módulo 4 · Técnicas

H2

> Técnicas de fisioterapia que utilizamos para la espalda y el cuello

Entradilla

> Las guías de lumbalgia recomiendan el ejercicio y sitúan la terapia manual solo dentro de un programa que lo incluya. Así lo planteamos: el ejercicio es el centro y lo demás lo acompaña. Las demás técnicas de la clínica se

> explican en la página de fisioterapia deportiva y readaptación.

H3 · Ejercicio terapéutico, movilidad y fuerza

> Es la base. Una revisión Cochrane analiza el ejercicio en el dolor lumbar crónico. Las guías de cuello y de espalda lo sitúan en primer lugar. Se pauta a su nivel y se sube poco a poco.

H3 · Terapia manual

> Masaje, movilizaciones y técnicas sobre músculos y articulaciones para aliviar el dolor y ganar movilidad. Sirve para facilitar el movimiento, no para sustituirlo.

H3 · Neuromodulación percutánea ecoguiada

> Una aguja muy fina junto a un nervio, guiada con ecografía, para aliviar algunos dolores persistentes. Es una técnica reciente con investigación todavía limitada; se considera un complemento del ejercicio, no un tratamiento único.

Módulo 5 · Lo que dicen las pruebas de imagen

H2

> Hernia, protrusión y resonancia: lo que dicen las pruebas de imagen

H3 · Un hallazgo en la resonancia no siempre explica el dolor

> Una revisión de 33 estudios con más de tres mil personas sin dolor encontró cambios en los discos en muchas de ellas. A los 20 años, casi tres de cada diez tenían una protrusión discal y cerca de cuatro de cada diez, desgaste de los discos. Con los años, esos hallazgos son todavía más frecuentes. Muchos forman parte del envejecimiento normal y no se asocian al dolor.

H3 · Por qué no se pide una resonancia de entrada

> La guía NICE recomienda no ofrecer pruebas de imagen de forma rutinaria en el dolor lumbar en atención no especializada. Si ya tiene una, tráigala: se interpreta junto con la exploración y con lo que usted siente.

H3 · Entonces, ¿una hernia importa?

> Importa cuando coincide con lo que le pasa: dolor que baja por la pierna, debilidad o pérdida de sensibilidad. Una hernia en una imagen no significa que deba dejar de moverse ni que necesite operarse. La cirugía es una decisión de su médico.

Módulo 6 · Quién le atiende

H2

> Quién le atiende

> Le atendemos en un **centro sanitario registrado**, con el número **CS 21018** de la Comunidad de Madrid. **José Luis González Coronado**, fisioterapeuta colegiado nº 15502 y responsable de la clínica, lleva su caso de principio a fin. `[PENDIENTE MUV: formación del fisioterapeuta, y foto con su permiso]`

Módulo 7 · Consejos y mitos

Eyebrow: Mientras tanto

H2

> Tres consejos para su espalda y tres mitos

H3 · Siga moviéndose

> Mantenerse activo ayuda más que acostarse a esperar. Camine y haga las tareas que pueda con un dolor que usted tolere.

H3 · Cambie de postura a menudo

> Si trabaja sentado, levántese y muévase cada cierto tiempo, aunque sean dos minutos.

H3 · Fortalezca poco a poco

> El ejercicio es uno de los tratamientos con más respaldo en el dolor lumbar persistente. Empiece con poca carga y súbala de forma gradual.

H3 · Mito: «Con dolor de espalda hay que hacer reposo»

> No. Una revisión Cochrane concluyó que mantenerse activo es igual o algo mejor que el reposo en cama en la lumbalgia aguda. En la ciática, la diferencia es escasa o nula.

H3 · Mito: «Con una hernia no se puede hacer ejercicio»

> No necesariamente. Las protrusiones aparecen también en personas sin dolor, y las guías recomiendan ejercicio para el dolor lumbar. Cómo y cuánto, se pauta tras la valoración.

H3 · Mito: «Mi resonancia dice que la espalda está desgastada»

> El desgaste que se ve en una imagen es frecuente, aumenta con la edad y suele formar parte del envejecimiento. No significa que su espalda esté rota.

Módulo 8 · Cuándo consultar antes con su médico

H2

> Cuándo conviene consultar antes con su médico

Entradilla

> La gran mayoría de los dolores de espalda no son graves. Pero algunas señales piden ver antes a su médico o ir a urgencias:

> - Pérdida de control de la vejiga o del intestino, o entumecimiento entre las piernas.
> - Debilidad que empeora en una pierna o en un brazo.
> - Fiebre con dolor de espalda.
> - Dolor tras una caída o un golpe fuerte.
> - Dolor constante por la noche que no mejora con la postura, sobre todo si hay antecedentes de cáncer o pérdida de peso inexplicada.
> - Dolor de cuello con dolor u opresión en el pecho, falta de aire o sudor frío: llame al 112.

Módulo 9 · Preguntas frecuentes

Eyebrow: Dudas habituales

H2

> Preguntas frecuentes sobre la fisioterapia de espalda y cuello

¿Es bueno ir al fisioterapeuta con una lumbalgia?

> Sí. Las guías recomiendan ejercicio y mantenerse activo, y el fisioterapeuta le ayuda a pautarlo con seguridad según su caso.

¿Qué ejercicios debo evitar con una lumbalgia?

> Depende de la fase. Al principio, evite lo que le dispare el dolor, pero no se quede quieto: el reposo absoluto no ayuda. Con la valoración se ajusta qué sí y qué no.

¿Cuántas sesiones hacen falta para una ciática?

> Depende de cada caso: la ciática es un síntoma con causas y evoluciones distintas. Tras la valoración se concreta el plan.

¿Es bueno caminar con ciática?

> Suele ser una de las primeras pautas: caminar a un ritmo que no aumente el dolor. Si al caminar el dolor le baja

> más por la pierna, cuéntenoslo.

¿Es bueno ir al fisioterapeuta con una hernia discal?

> Sí. El ejercicio y la educación son la base del tratamiento, y no hace falta dejar de moverse. La cirugía se valora solo en casos concretos.

¿Qué hace un fisioterapeuta en las cervicales?

> Valora la movilidad y la fuerza del cuello, trata la tensión muscular con técnicas manuales y pauta ejercicios para mantener el resultado.

¿Qué diferencia hay entre un médico rehabilitador y un fisioterapeuta?

> El médico rehabilitador es un médico especialista: diagnostica, puede pedir pruebas y recetar. El fisioterapeuta valora y trata con técnicas físicas y ejercicio.

¿Necesito una resonancia para empezar?

> No. Las guías recomiendan no pedirla de forma rutinaria en el dolor lumbar. Si ya tiene una, tráigala.

Módulo 10 · Dónde estamos y cuándo abrimos

H2

> Dónde estamos y cuándo abrimos

Ficha de contacto

> **MUV Tres Cantos** · Av. de Madrid, 19, Loc 5 · 28760 Tres Cantos
>
> **Horario:** de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00; los sábados, de 9:00 a 14:00. Los domingos cerramos.
>
> **Teléfono:** 614 13 14 05
>
> `[PENDIENTE MUV: aparcamiento, accesibilidad de la entrada y transporte]`

Cómo llegar

> Todo sobre el acceso, el aparcamiento y la entrada está en la página de MUV Tres Cantos.

Botón

> `[Pedir cita para valorar su espalda]`

Enlaces internos del texto

Módulo	Texto del enlace	Destino
Cómo trabajamos	entrenamiento funcional supervisado en Tres Cantos	`/sedes/tres-cantos/entrenamiento-funcional`
Técnicas	fisioterapia deportiva y readaptación	`/sedes/tres-cantos/fisioterapia-deportiva`
Dónde estamos y cuándo abrimos	MUV Tres Cantos	`/sedes/tres-cantos#como-llegar`

Fuentes (pie de la página, en letra pequeña)

1. NICE. *Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management (NG59).* 2016, modificada en 2026.
2. Foster NE et al. *Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions.* Lancet 2018. PMID 29573872.
3. Hayden JA et al. *Exercise therapy for chronic low back pain.* Cochrane Database Syst Rev 2021. PMID 34580864.
4. Dahm KT et al. *Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica.* Cochrane Database Syst Rev 2010. PMID 20556780.
5. Choi BK et al. *Exercises for prevention of recurrences of low-back pain.* Cochrane Database Syst Rev 2010. PMID 20091596.
6. Brinjikji W et al. *Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations.* AJNR 2015. PMID 25430861.
7. Blanpied PR et al. *Neck Pain: Revision 2017.* JOSPT 2017. PMID 28666405.

Datos pendientes de la clínica (lista completa)

Lo que contenidos está pidiendo a los dueños. Mientras no llegue, lo que dependa de ello **no se maqueta ni se rellena**.

Dato	De quién
Formación del fisioterapeuta y foto con su permiso	Dueño de Tres Cantos
Aparcamiento, accesibilidad y transporte	Dueño de Tres Cantos
Revisión clínica de consejos, mitos y señales de alarma	Fisioterapeuta de la clínica

Notas de maquetación

- **Enlazado:** el módulo 4 enlaza a `/sedes/tres-cantos/fisioterapia-deportiva`; el módulo 10 a `/sedes/tres-cantos#como-llegar`. La página de sede debe enlazar a esta con «fisioterapia de espalda en Tres Cantos» en el

ancla.

- **Marcado:** `BreadcrumbList`, `FAQPage` (las 8 preguntas, todas con respuesta publicada) y el servicio con `provider` apuntando al `@id` del `MedicalClinic` de la sede. Nada de `aggregateRating`, nada de `areaServed`.
- **ALT de las imágenes:** pendientes de elegir las fotos de la galería de Tres Cantos (la primera es de fisioterapia pediátrica, que esta sede no presta: no usarla aquí).
- **Cita:** el botón abre el selector de sede ya existente.